



HANSENÍASE – MANEJO NA APS

Iolanda Felipe da Silva Bona
Médica de Família e Comunidade
IESCVII



OBJETIVOS:

- 1. Abordar epidemiologia, transmissão, diagnóstico, apresentação clínica e conduta para a Hanseníase na APS.*
- 2. Conhecer medidas de prevenção e controle da hanseníase.*
- 3. Compreender a abordagem diagnóstica às lesões de pele.*
- 4. Compreender o acompanhamento e as políticas públicas para Hanseníase.*
- 5. Abordar lei do sigilo (Dez 2021).*

- Também conhecida como mal de Hansen, lepra ou simplesmente MH, é uma doença infecciosa causada pelo *Mycobacterium leprae*, ou bacilo de Hansen.
- O *M. leprae* é um bacilo álcool-ácido-resistente, parasita intracelular obrigatório, com afinidade por células cutâneas e células dos nervos periféricos (células de Schwann), sítios em que ele pode proliferar-se.
- ❑ Caracteriza-se por alta infectividade e baixa patogenicidade, significando que muitos se infectam e poucos adoecem.
- ❑ Afeta primariamente os nervos periféricos e a pele, podendo acometer também a mucosa do trato respiratório superior, olhos, linfonodos, testículos e órgãos internos, de acordo com o grau de resistência imune do indivíduo infectado.



- O homem é considerado o único reservatório natural do bacilo.
- A doença cursa com neuropatia em graus variados, podendo causar incapacidades físicas e perda funcional, especialmente nas mãos, nos pés e nos olhos, que podem ser muito graves em casos com diagnóstico tardio.
- É transmitida, predominantemente, pela mucosa do trato respiratório, através de aerossóis e secreções nasais, por um doente da forma contagiosa sem tratamento para outra pessoa de seu convívio.
- Não se conhece precisamente o período de incubação da doença, mas se estima que dure em média cinco anos.
- É uma doença de notificação compulsória em todo o território nacional.

- A hanseníase ocorre em pessoas de todos os níveis socioeconômicos, com maior incidência nos mais baixos, onde a multiexposição está ligada a menores níveis de instrução, moradia e nutrição.
- Acomete ambos os sexos, porém os homens apresentam formas mais graves e sofrem mais deformidades.
- Ocorre em todas as idades, sobretudo em adultos entre 20 e 50 anos.
- É uma doença infecciosa de evolução crônica que, embora curável, ainda permanece endêmica em várias regiões do mundo, principalmente na Índia, no Brasil e na Indonésia.
- No Brasil, ainda é considerada um importante desafio em saúde pública.

- O diagnóstico precoce e o tratamento oportuno são dificultados pelo estigma e discriminação associados ao medo e à falta de conhecimento sobre a doença, além da qualificação inadequada de grande parte dos profissionais de saúde.
- Os sinais e sintomas da doença podem ser discretos, especialmente nas suas manifestações iniciais e nas formas paucibacilares, passando despercebidos.
- Desse modo, a realização de atividades de educação em saúde para a população e a busca ativa são estratégias essenciais para a detecção de casos e devem ser periodicamente realizadas, principalmente em áreas endêmicas.



- Deve-se suspeitar de hanseníase em pessoas com qualquer um dos seguintes sintomas e sinais:

- ❑ Manchas hipocrômicas ou avermelhadas na pele;
- ❑ Perda ou diminuição da sensibilidade em mancha(s) da pele;
- ❑ Dormência ou formigamento de mãos/pés;
- ❑ Dor ou hipersensibilidade em nervos;
- ❑ Edema ou nódulos na face ou nos lóbulos auriculares;
- ❑ Ferimentos ou queimaduras indolores nas mãos ou pés.



DIAGNÓSTICO

- É essencialmente clínico e epidemiológico, realizado por meio da análise da história, das condições de vida do indivíduo e do exame dermatoneurológico.
- Em poucas situações, é necessária a utilização de exames laboratoriais ou de exames complementares.
- É considerado um caso de hanseníase o indivíduo que apresenta pelo menos uma das características a seguir:
 - ❑ Lesão(ões) e/ou área(s) da pele com alteração de sensibilidade;
 - ❑ Acometimento de nervo(s) periférico(s), com ou sem espessamento, associado a alterações sensitivas e/ou motoras e/ou autonômicas;
 - ❑ Baciloscopia positiva de esfregaço intradérmico.

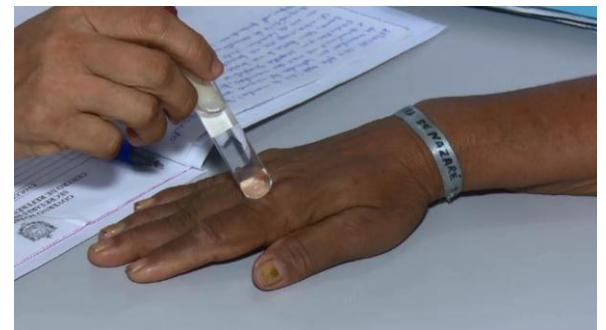
ANAMNESE



- Deve ser valorizada qualquer alteração na pele, bem como o tempo de seu aparecimento e sua evolução; possíveis alterações de sensibilidade; presença de dores nos nervos periféricos, assim como fraqueza de mãos e/ou pés e câibras.
- É importante levar em conta a área de residência do indivíduo, a sua história pregressa relativa ao convívio em territórios endêmicos e, especialmente, o convívio com indivíduos acometidos pela doença.
- Sempre questionar se algum parente próximo apresenta alterações semelhantes.
- Uma história epidemiológica negativa para hanseníase não exclui seu diagnóstico.

EXAME FÍSICO

- Deve incluir a observação cuidadosa de toda a superfície cutânea, sob boa iluminação, procedendo-se aos testes de sensibilidade em lesões da pele e/ou em áreas referidas pelo indivíduo como de sensibilidade alterada, ainda que sem lesões dermatológicas.
- Para chegar ao diagnóstico de hanseníase, o exame dermatoneurológico e a correta interpretação dos achados são de importância fundamental.
- Pesquisam-se três modalidades de sensibilidade: térmica, dolorosa e tátil, que se alteram nesta ordem.



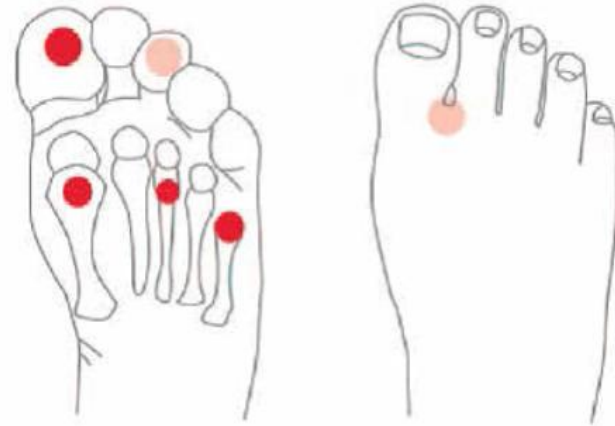
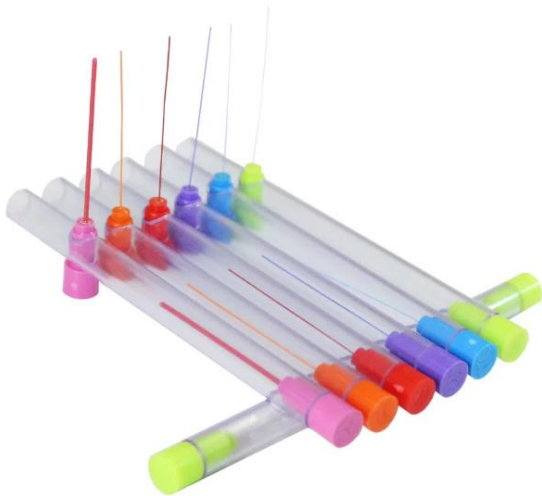
- A sensibilidade térmica pode ser testada tocando-se a pele com tubos de ensaio contendo água quente e fria. O paciente deve identificar as temperaturas, se quente ou fria. Na impossibilidade de se fazer o teste com água quente e fria, pode ser usado um procedimento alternativo, com algodão embebido em éter, que corresponderá à sensação de frio, e outro seco.
- A sensibilidade dolorosa pode ser pesquisada com alfinete ou agulha de injeção descartáveis e esterilizados, devendo o paciente identificar se é a ponta ou o fundo da agulha ou alfinete que está tocando a sua pele.
- A sensibilidade tátil pode ser testada com uma fina mecha de algodão seco, solicitando-se que o paciente aponte a área tocada.



- A avaliação neurológica é realizada por meio da inspeção e da pesquisa de sensibilidade de olhos, mãos e pés, inspeção do nariz e avaliação da força muscular de mãos e pés.
- Também deve ser feita a avaliação dos principais troncos nervosos periféricos: facial e trigêmeo (avaliação indireta por meio do exame dos olhos) e a palpação dos nervos radial, ulnar, mediano, fibular e tibial.
- Os troncos nervosos devem ser palpados, buscando-se alterações de espessura, consistência e dor (neurite).
- É importante que seja feita a comparação com o nervo contralateral, pois as variações individuais são grandes.



- A estesiometria de lesões cutâneas e de áreas da pele para detecção de lesão neural com os monofilamentos de Semmes-Weinstein tem sido utilizada tanto nos serviços de atenção primária quanto nos centros de referência.
- É um método quantitativo, de fácil aplicação, seguro, de baixo custo, com grande sensibilidade, especificidade e reprodutibilidade, quando comparado a outros métodos eletrofisiológicos.



EXAMES COMPLEMENTARES



BACILOSCOPIA DE PELE

- O esfregaço dérmico é coletado de preferência nas lesões suspeitas, nos lóbulos e nos cotovelos.
 - ❑ A coloração é feita pelo método de Ziehl-Neelsen.
 - ❑ O resultado é expresso na forma de índice baciloscópico (IB) em uma escala que vai de 0 a 6+.
- Mostra-se negativa nas formas paucibacilares (indeterminada e tuberculoide), fortemente positiva na forma virchowiana e tem resultados variáveis nos casos dimorfos.
- É importante lembrar-se de que a baciloscopia negativa não afasta o diagnóstico.



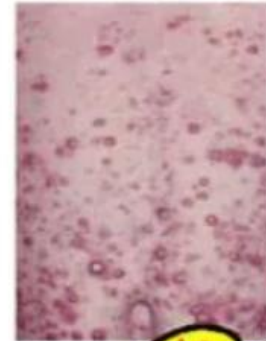
**FORMA
TUBERCULÓIDE**

ou

**FORMA
DIMORFA**

ou

**FORMA
VIRCHOWIANA**



OUTROS TESTES DIAGNÓSTICOS

- A **Avaliação Neurológica Simplificada** (ANS) é um exame de caráter obrigatório e tem por objetivo monitorar a função neural do paciente, verificando se há alterações autonômicas, comprometimento da sensibilidade ou diminuição da força muscular.
- O **exame histopatológico** é empregado nos casos em que o diagnóstico persiste indefinido mesmo após a avaliação clínica e baciloscópica.
- A **ultrassonografia de nervos periféricos** contribui diretamente para a avaliação do dano neural.
- A **eletroneuromiografia** (ENMG) é útil para demonstrar o comprometimento do nervo e, às vezes, pode ser utilizada para o diagnóstico.

Nome: _____ DataNasc: ____/____/____
 Ocupação: _____ Sexo: M ☐ F ☐
 Município: _____ Unidade Federada: _____
 Classificação Operacional: PB ☐ MB ☐ Data Início PQT: ____/____/____ Data Alta PQT: ____/____/____

FACE	1ª	2ª	3ª
Nariz	D E	D E	D E
Queixa principal			
Ressacamento (S/N)			
Perda (S/N)			
Perfuração de septo (S/N)			
Olfato	D E	D E	D E
Queixa principal			
Fecha olhos e/força (mm)			
Fecha olhos e/força (mm)			
Triângulo(S/N) / Estirpado(S/N)			
Dimin. sensib. córnea (S/N)			
Opacidade córnea (S/N)			
Catarata (S/N)			
Acuidade Visual			

Legenda: N = não S = Sim

Membros Superiores	1ª	2ª	3ª
Queixa principal			
Palpação de nervos	D E	D E	D E
Ulnar			
Mediano			
Radial			

Legenda: N = normal E = espessado D = dor

Avaliação da Força	1ª	2ª	3ª
	D E	D E	D E
Abrir dedo mínimo			
Abdução do 5º dedo (nervo ulnar)			
Eleva o polegar			
Abdução do polegar (nervo mediano)			
Eleva o punho			
Extensão do punho (nervo radial)			

Legenda: F=Força D=Diminuída P=Paralisado ou 5=Força, 4=Resistência Parcial, 3=Movimento completo, 2=Movimento Parcial, 1=Contração, 0=Paralisado

Inspeção e Avaliação Sensitiva

1ª	2ª	3ª
D E	D E	D E

Legenda: Caneta/filamento 11a(2g): Sente ✓ Não sente X ou Monofilamentos: seguir cores
 Garra móvel: M Garra rígida: R Reabsorção: Ferida: ○

MEMBROS INFERIORES	1ª	2ª	3ª
Queixa principal			
Palpação de nervos	D E	D E	D E
Fibular			
Tibial posterior			

Legenda: N = normal E = espessado D = dor

Avaliação da Força	1ª	2ª	3ª
	D E	D E	D E
Eleva o hálux			
Extensão de hálux (nervo fibular)			
Eleva o pé			
Dorsiflexão de pé (nervo fibular)			

Legenda: F=Força D=Diminuída P=Paralisado ou 5=Força, 4=Resistência Parcial, 3=Movimento completo, 2=Movimento Parcial, 1=Contração, 0=Paralisado

Inspeção e Avaliação Sensitiva

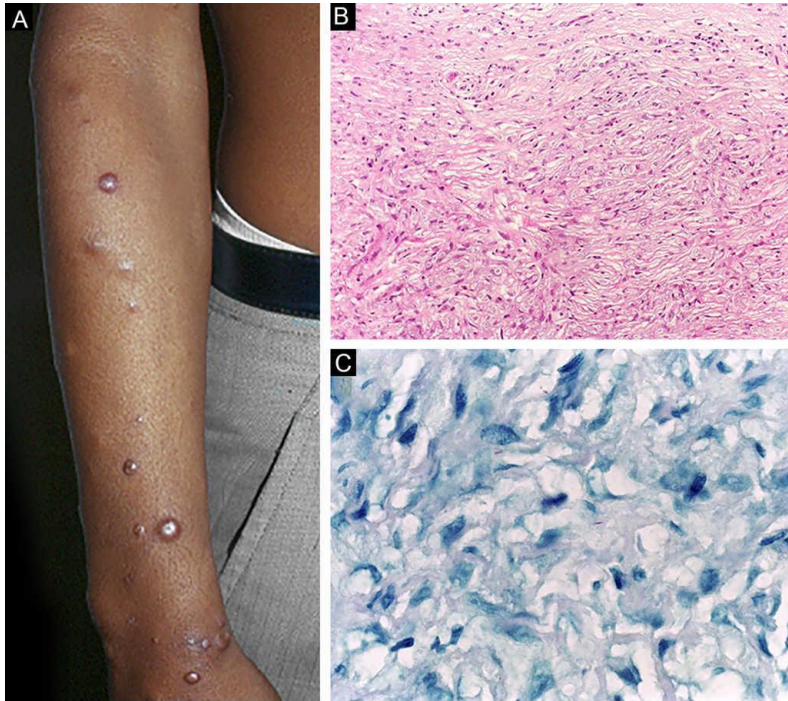
1ª	2ª	3ª
D E	D E	D E

Legenda: Caneta/filamento 11a(2g): Sente ✓ Não sente X ou Monofilamentos: seguir cores
 Garra móvel: M Garra rígida: R Reabsorção: Ferida: ○

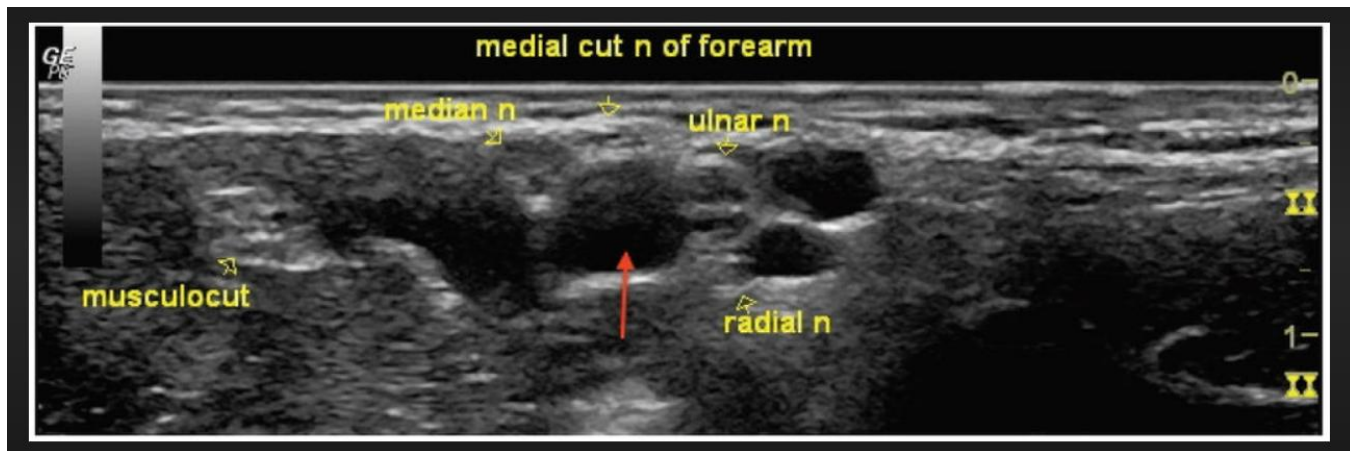
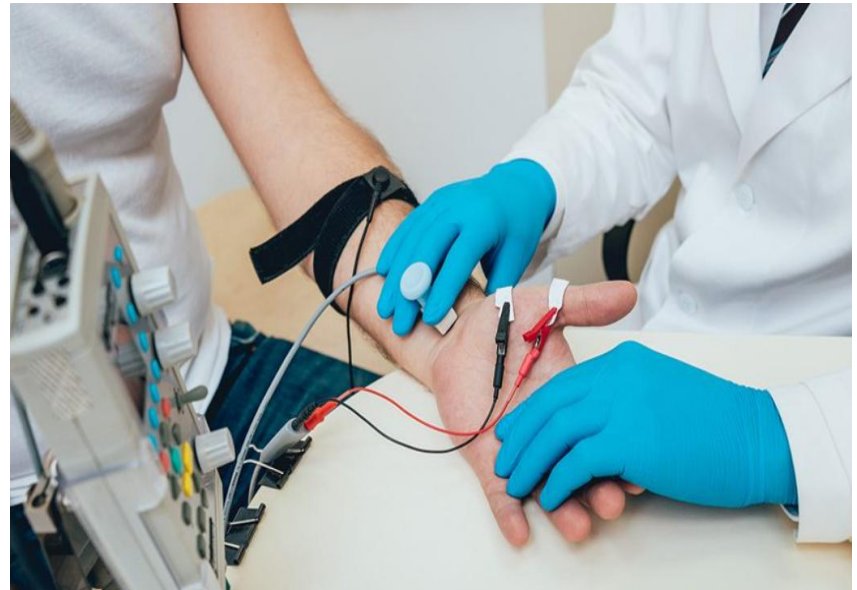
CLASSIFICAÇÃO DO GRAU DE INCAPACIDADE (OMS)

DATA DA AVALIAÇÃO	OLHOS	MÃOS	PÉS	MAIOR GRAU	ASSINATURA
	D E	D E	D E		
Avaliação no diagnóstico					
Avaliação na alta					

Fonte: Ministério da Saúde, Brasil.



An Bras Dermatol 10.1016/j.abdp.2022.02.009



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

- A principal diferença entre hanseníase e outras doenças dermatológicas é a perda da sensibilidade nas lesões de pele, sempre presente na primeira.

Vitiligo



Esclerose Tuberosa



Nevo acrômico



Leishmaniose Tegumentar



Granuloma anular



Sífilis Terciária



Tinha do corpo



CLASSIFICAÇÃO OPERACIONAL

- Após a conclusão diagnóstica, os casos de hanseníase devem ser classificados para fins de tratamento, de acordo com os critérios definidos pela OMS.

Hanseníase Paucibacilar
(PB)

Caracteriza-se pela presença de uma a cinco lesões cutâneas e baciloscopia obrigatoriamente negativa.

Hanseníase Multibacilar
(MB)

Caracteriza-se pela presença de mais de cinco lesões de pele e/ou baciloscopia positiva.

*Todos os casos de hanseníase que suscitem dúvida sobre a classificação operacional devem ser tratados como MB.

FORMAS CLÍNICAS

- Embora a classificação com base no número de lesões seja suficiente para a escolha adequada do esquema terapêutico, o reconhecimento das formas clínicas é de grande valor, pois auxilia na identificação dos sinais e sintomas ligados a cada forma da doença.
- Essa ideia deu origem à Classificação de Madri (1953), que se baseia nos achados do exame físico e dos exames complementares, mas considera que o critério básico deve ser clínico, abrangendo a morfologia das lesões cutâneas e as manifestações neurológicas.
- Considera dois polos estáveis e opostos (tuberculoide e virchowiano) e dois grupos instáveis (indeterminado e dimorfo), que, na evolução natural da doença, evoluiriam para um dos polos.

Hanseníase Indeterminada



Hanseníase Tuberculóide



Hanseníase Dimorfa



Hanseníase Virchowiana



1) INDETERMINADA

- Muitas vezes aparece como manifestação inicial da doença após período de incubação que varia, em média, de 2 a 5 anos.
- Pode passar despercebida e evoluir para cura espontânea ou para outra forma clínica.
- Caracteriza-se por uma ou poucas manchas hipocrômicas ou eritemato-hipocrômicas com alteração de sensibilidade térmica, sem acometimento dos nervos periféricos.
- A forma inicial pode manifestar-se apenas por áreas com distúrbios de sensibilidade, sem alteração da cor da pele.
- A baciloscopia é negativa.



Forma Clínica	Aspectos Clínicos	Baciloscopia	Classificação Operacional
Indeterminada	Áreas de hipo ou anestesia, manchas hipocrômicas e/ou eritemato-hipocrômicas, com ou sem diminuição da sudorese e rarefação de pelos, sem comprometimento dos nervos.	Negativa	PB



2) TUBERCULOIDE

- Surge a partir da forma indeterminada não tratada, em indivíduos com boa resistência da imunidade celular.
- Apresenta tendência a não se disseminar, ficando limitada às áreas iniciais e podendo evoluir para cura espontânea.
- Manifesta-se por uma ou poucas lesões eritemato-hipocrômicas, eritematosas, com limites bem definidos ou discretamente elevados ou micropapuloses, com marcada alteração de sensibilidade térmica, dolorosa e tátil.
- O comprometimento dos anexos cutâneos pode levar a alopecia e anidrose nas lesões e nas áreas acometidas, mesmo na ausência de manchas.
- Alguns nervos periféricos podem ser afetados.
- A baciloscopia é negativa.



Forma Clínica	Aspectos Clínicos	Baciloscopia	Classificação Operacional
Tuberculoide	Placas eritematisas, eritemato-hipocrômicas, bem-delimitadas, hipo ou anestésicas, podendo ocorrer comprometimento de nervo.	Negativa	PB



3) DIMORFA

- Manifesta-se por lesões eritematosas, eritematovioláceas, ferruginosas, infiltradas, edematosas, brilhantes, escamosas, com contornos internos bem delimitados e externos maldefinidos (**lesões foveolares**), com centro deprimido e aparentemente poupado, hipocrômicas ou de coloração normal da pele, hipoestésicas ou anestésicas.
- O caráter instável faz com que haja grande variedade morfológica em sua apresentação clínica; as lesões podem ser semelhantes às bem delimitadas da hanseníase tuberculoide e/ou às disseminadas da hanseníase virchowiana.
- O acometimento de nervos periféricos e os estados reacionais são frequentes, acarretando elevado potencial incapacitante.
- A baciloscopia pode ser negativa ou positiva.



Forma Clínica	Aspectos Clínicos	Baciloscopia	Classificação Operacional
Dimorfa	Lesões pré-foveolares (eritematosas e planas com centro claro), lesões foveolares (eritematopigmentares de tonalidade ferruginosa ou pardacenta), apresentando alteração na sensibilidade.	Positiva ou Negativa	MB



4) VIRCHOWIANA

- As manchas, no início hipocrômicas, tornam-se eritematosas, infiltradas e ferruginosas, disseminando-se simetricamente por todo o tegumento.
- Surgem pápulas, nódulos, tubérculos, infiltrações em placas, acometendo, com frequência, face, orelhas e extremidades, levando à perda das sobrancelhas e dos cílios (madarose).
- Ocorre comprometimento dos nervos superficiais da pele, da inervação vascular e dos nervos periféricos, estes levando a deformidades de aparecimento mais tardio.
- É uma doença sistêmica, com manifestações mucosas e viscerais importantes.

- É frequente e precoce o acometimento da mucosa nasal, com o surgimento de sintomas semelhantes aos da gripe ou da rinite alérgica (congestão nasal, coriza e epistaxe) e, na ausência de tratamento específico e orientações adequadas, poderá evoluir para perfuração de septo e desabamento nasal.
- As complicações oculares são frequentes: logoftalmo (lesão do nervo facial), anestesia da córnea (lesão do ramo oftálmico do nervo trigêmeo), entrópio, ectrópio, triquíase, conjuntivite, ceratite, irite, iridociclite, glaucoma e catarata.
- A baciloscopia é fortemente positiva.
- Os casos sem tratamento constituem importante foco na manutenção da cadeia de transmissão da doença.



Forma Clínica	Aspectos Clínicos	Baciloscopia	Classificação Operacional
Virchowiana	Eritema e infiltração difusos, placas eritematosas, infiltradas e de bordas mal definidas, tubérculos e nódulos, madarose, lesões das mucosas, com alteração de sensibilidade.	Positiva	MB



5) NEURAL PURA OU PRIMÁRIA

- Casos de hanseníase unicamente com comprometimento de nervo, sem lesões cutâneas.
- Podem ser encontrados nas formas tuberculoide e dimorfa.
- As manifestações neurais são, em geral, assimétricas, envolvendo um ou vários nervos periféricos.
- As alterações sensitivas costumam ocorrer mais cedo do que as motoras, iniciando com dormência, perda do tato, da sensibilidade ao calor, da dor e da pressão.
- Outras alterações incluem pele seca, anidrótica e presença de fissuras e úlceras.

CONTATOS

- “Toda e qualquer pessoa que resida ou tenha residido, conviva ou tenha convivido com o doente de hanseníase, no âmbito domiciliar, nos últimos cinco anos anteriores ao diagnóstico da doença, podendo ser familiar ou não”.
- Recomenda-se ofertar imunoprevenção aos contatos de pacientes com hanseníase, maiores de um ano de idade, não vacinados ou que receberam apenas uma dose da vacina BCG.

Contatos prolongados de portadores de hanseníase: vacinação seletiva, nas seguintes situações:

Menores de 1 (um) ano de idade:

- **Não vacinados:** administrar 1 (uma) dose de BCG;
- **Comprovadamente vacinados que apresentem cicatriz vacinal:** não administrar outra dose de BCG.
- **Comprovadamente vacinados que não apresentem cicatriz vacinal:** administrar 1 (uma) dose de BCG 6 (seis) meses após a última dose.

A partir de 1 (um) ano de idade:

- **Sem cicatriz:** administrar 1 (uma) dose;
- **Vacinados com 1 (uma) dose:** administrar outra dose de BCG, com intervalo mínimo de 6 (seis) meses após a dose anterior;

*Recomenda-se fazer um exame anual por 5 anos nos contatos que não apresentaram lesão.

REAÇÕES HANSÊNICAS

- São as complicações mais frequentes em uma pessoa com hanseníase.
- São processos inflamatórios agudos no decorrer da infecção crônica hansênica.
- Resultam da ativação de resposta imune contra o *M. leprae* e podem ocorrer antes, durante ou após o tratamento da infecção.
- Caso aconteçam durante o tratamento, este não deverá ser interrompido, mas, caso aconteçam posteriormente ao término da PQT, o mesmo não deve ser reiniciado.
- As reações hansênicas tipo 1 (ou reação reversa) e tipo 2 (ou eritema nodoso hansênico) devem ser diagnosticadas e tratadas com urgência, para se evitarem os danos neurais delas decorrentes e as possíveis incapacidades causadas pela neurite.

Sinais e sintomas	Reação tipo I	Reação tipo II
Forma clínica	PBs e MBs (mais frequentemente)	MBs
Área envolvida	Mais localizado nas lesões preexistentes	Generalizada/sistêmica
Inflamação da pele	As lesões de pele estão inflamadas (eritema e edema), mas o resto da pele está normal	Nódulos sensíveis ao toque, vermelho-violáceos, independentemente da localização das lesões preexistentes
Acometimento neural	Frequente	Menos frequente
Estado geral do paciente	Bom, sem febre ou com febre baixa	Ruim, com febre e mal-estar geral
Tempo de aparecimento e tipo de paciente	Precocemente durante a PQT, tanto em paciente PB quanto em MB	Mais tardiamente no curso do tratamento; apenas nos casos MBs
PBs, paucibacilares; MBs, multibacilares; PQT, poliquimioterapia.		

Reação hansênica tipo 1 (ou reação reversa)



Reação hansênica tipo 2 (ou eritema nodoso hansênico)



Quadro 205.8 | Esquemas terapêuticos para os estados reacionais

Reação tipo I

Prednisona na dose de 1-1,5 mg/kg/dia (D)

Reação tipo II

Talidomida 100-400 mg/dia (D); introduzir corticosteroide em caso de comprometimento de nervos, segundo o esquema para reação tipo I

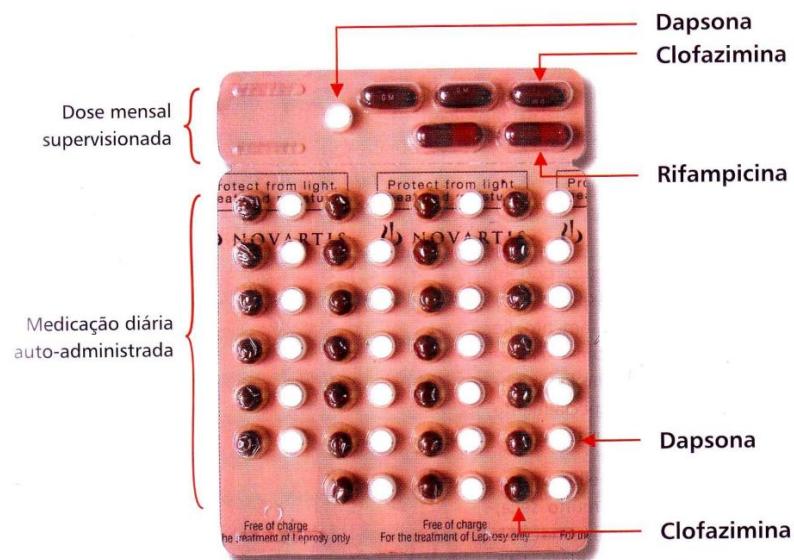
Dicas

- ▶ Na utilização da prednisona, devem ser tomadas algumas precauções:⁷⁻⁹
- ▶ Registro do peso, da pressão arterial (PA) e da glicemia de jejum no sangue para controle.
- ▶ Tratamento antiparasitário com medicamento específico para *Strongiloides stercoraria*, prevenindo a disseminação sistêmica desse parasita (tiabendazol 50 mg/kg/dia, em 3 doses por 2 dias, ou 1,5 g/dose única, ou albendazol na dose de 400 mg/dia, durante 3 dias consecutivos).
- ▶ Profilaxia da osteoporose: cálcio 1.000 mg/dia, vitamina D 400-800 UI/dia ou bisfosfonatos (p. ex., alendronato 10 mg/dia).
- ▶ A talidomida é contraindicada em mulheres em idade fértil (Lei nº 10.651, de 16 de abril de 2003) devido a seu efeito teratogênico (focomelia). Nesses casos, usar pentoxifilina na dose de 400 mg, 3x/dia, mantida por 2 a 3 meses após melhora do quadro, às vezes associada à prednisona 0,5 mg/kg/dia.⁷⁻⁹

TRATAMENTO

- Todo paciente deve ser informado no diagnóstico que, com o tratamento adequado, a doença será curada.
- Os objetivos primordiais são a cura da infecção mediante a antibioticoterapia e a prevenção tanto das incapacidades físicas como do comprometimento da função neurológica.
- Até recentemente, a PQT era administrada em dois esquemas terapêuticos distintos, sendo:
 - ❑ Rifampicina, clofazimina e dapsona para casos multibacilares;
 - ❑ Rifampicina e dapsona, destinado aos paucibacilares.

- Desde 2018 a OMS passou a preconizar o uso dos três medicamentos para o tratamento de todos os casos de hanseníase, mantendo o tempo de 6 meses para casos PB e de 12 meses para os casos MB.
- No Brasil, esse esquema terapêutico foi oficialmente adotado em 2021, quando passou a ser denominado de PQT-U.
- A gravidez e o aleitamento não contraindicam o tratamento.



Faixa etária e peso corporal	Apresentação	Posologia	Duração do tratamento ^a	
			MB	PB
Pacientes com peso acima de 50kg	PQT-U Adulto	Dose mensal supervisionada: · Rifampicina 600mg · Clofazimina 300mg · Dapsona 100mg Dose diária autoadministrada: · Clofazimina 50mg diariamente · Dapsona 100mg diariamente	12 meses	6 meses
Crianças ou adultos com peso entre 30 e 50kg	PQT-U Infantil	Dose mensal supervisionada: · Rifampicina 450mg · Clofazimina 150mg · Dapsona 50mg Dose diária autoadministrada: · Clofazimina 50mg em dias alternados · Dapsona 50mg diariamente	12 meses	6 meses
Crianças com peso abaixo de 30kg	Adaptação da PQT-U Infantil ^{b,c}	Dose mensal supervisionada: · Rifampicina 10mg/kg de peso · Clofazimina 6mg/kg de peso · Dapsona 2mg/kg de peso Dose diária autoadministrada: · Clofazimina 1mg/kg de peso/dia · Dapsona 2mg/kg de peso/dia	12 meses	6 meses

Medicamento	Eventos adversos
Rifampicina	Pode ocorrer hepatotoxicidade com leve aumento transitório das transaminases hepáticas, mas essa reação é rara na dosagem e nos intervalos recomendados para hanseníase, não sendo uma indicação para interromper o tratamento. Como a rifampicina é administrada apenas em uma dose mensal no esquema PQT-U, os eventos adversos reconhecidos de seu uso na tuberculose raramente são vistos. Uma dose mensal de rifampicina provavelmente não causa indução do citocromo hepático P450, mas esse resultado nunca foi medido formalmente.
Dapsona	A dapsona geralmente é bem tolerada nas doses recomendadas para a hanseníase, mas pode causar hemólise e, mais raramente, anemia significativa. A deficiência de glicose-6-fosfato desidrogenase raramente aumenta esse risco, não sendo necessário testar rotineiramente os níveis da enzima antes do início da PQT-U. Recomenda-se, sempre que possível, o monitoramento dos níveis hematológicos nos primeiros meses de tratamento. São descritos casos raros de hepatopatia, nefropatia, agranulocitose e psicose.
Clofazimina	O efeito mais comum e perceptível é a pigmentação da pele, variando de vermelho a castanho-escuro, dependendo da dosagem. O fármaco pode acumular-se nas lesões cutâneas ativas da hanseníase, tornando-as mais evidentes. A pigmentação geralmente desaparece dentro de seis a 12 meses após a interrupção da clofazimina, embora traços de descoloração ainda possam permanecer por até quatro anos. Pode haver coloração rosada da urina, expectoração e suor, especialmente após a ingestão da dose mensal supervisionada. A clofazimina também produz ictiose característica nas pernas e antebraços. Os efeitos gastrointestinais, que variam de cólicas leves a diarreia e perda de peso, podem ocorrer como resultado da deposição de cristais de clofazimina na parede do intestino delgado, especialmente no uso contínuo de doses elevadas do fármaco. A pigmentação da pele não deve ser considerada critério para suspensão do medicamento, exceto quando há insatisfação extrema do paciente, com risco de abandono do tratamento.

- A regressão das lesões dermatológicas da hanseníase, durante e após o uso da poliquimioterapia, é bastante variável, podendo levar meses ou anos para ocorrer.
- Quando, após a PQT-U, houver persistência de lesões dermatológicas que cheguem a suscitar dúvidas sobre a resposta terapêutica, a resistência medicamentosa deve ser investigada.



- Critério de alta: 6 doses supervisionadas em até 9 meses da PB e 12 doses supervisionadas em até 18 meses na MB.
- No momento da alta por cura, os indivíduos devem ser informados sobre a manutenção do risco de episódios reacionais e/ou neurite.
- Os casos de recidiva em hanseníase são raros e em geral ocorrem em período superior a 5 anos após a cura.
- Todos os casos suspeitos de recidiva devem ser confirmados por unidades de referência.

LEI DO SIGILO (Nº14.289)

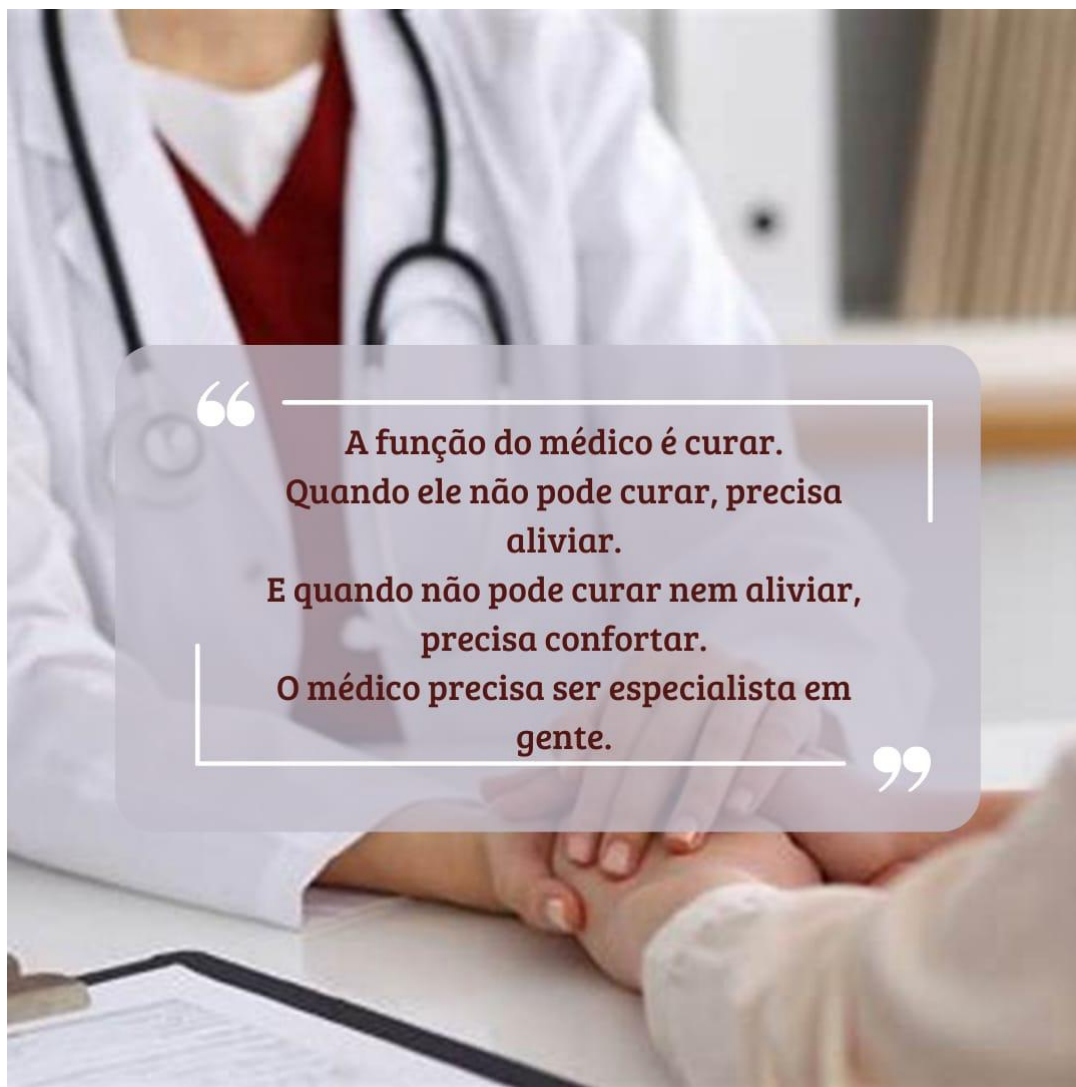
- Obriga o sigilo sobre a condição de pessoas infectadas pelo vírus HIV, hepatites crônicas, hanseníase ou tuberculose.
- É uma forma de evitar constrangimento ou surgimento de outras barreiras sociais que atrapalhem essas pessoas de desfrutar da plena cidadania.
- A medida é clara ao explicitar que o atendimento em serviços de saúde, públicos ou privados, será organizado de forma a não permitir a identificação, pelo público em geral, da condição da pessoa que convive com uma dessas doenças.
- O sigilo profissional somente poderá ser quebrado nos casos previstos na legislação, por justa causa ou por autorização expressa da pessoa com o vírus.



Referências Bibliográficas:

GUSSO, G, et al. Tratado de medicina de família e comunidade - 2 volumes: princípios, formação e prática. Disponível em: Minha Biblioteca, (2nd edição). Grupo A, 2019. Cap. 205.

DUNCAN, B, B. et al. Medicina ambulatorial: condutas de atenção primária baseadas em evidências. Disponível em: Minha Biblioteca, (5th edição). Grupo A, 2022. Cap. 150.



“

A função do médico é curar.
Quando ele não pode curar, precisa
aliviar.

E quando não pode curar nem aliviar,
precisa confortar.

O médico precisa ser especialista em
gente.

”

Obrigada!